

I. Khái niệm cốt lõi cần nhớ

- **Phản vệ:** Là phản ứng dị ứng ở người, xuất hiện nhanh từ vài giây đến vài giờ sau khi tiếp xúc với dị nguyên, có thể dẫn đến tử vong nhanh chóng.
- **Sốc phản vệ:** Là mức độ nặng nhất của phản vệ (gây giãn mạch và co thắt phế quản đột ngột), có thể gây tử vong trong vài phút.
- **Adrenalin:** Là thuốc thiết yếu, quan trọng hàng đầu và duy nhất có thể cứu sống người bệnh bị phản vệ.

II. Phân độ phản vệ (Rất quan trọng để ra quyết định xử trí)

Lưu ý: Mức độ phản vệ có thể nặng lên rất nhanh và không theo tuần tự.

- **Nhẹ (Độ I):** Chỉ có biểu hiện ở da và niêm mạc như mào đay, ngứa, phù mạch.
- **Nặng (Độ II):** Có từ 2 biểu hiện ở nhiều cơ quan như da (mào đay nhanh), hô hấp (khó thở, tức ngực), tiêu hóa (đau bụng, nôn), nhưng huyết áp chưa tụt hoặc tăng.
- **Nguy kịch (Độ III):** Biểu hiện nặng như đường thở có tiếng rít thanh quản, tím tái, rối loạn ý thức, tụt huyết áp, sốc mạch nhanh nhỏ.
- **Ngừng tuần hoàn (Độ IV):** Bệnh nhân ngừng hô hấp, ngừng tuần hoàn.

III. Hướng dẫn xử trí cấp cứu

- **Đối với phản vệ nhẹ (Độ I):** Sử dụng thuốc Methylprednisolon hoặc Diphenhydramin (uống hoặc tiêm) và bắt buộc tiếp tục theo dõi ít nhất 24 giờ để phòng ngừa chuyển nặng.
- **Đối với phản vệ từ Độ II trở lên:** Phải ngừng ngay tiếp xúc với dị nguyên và **tiêm bắp ngay Adrenalin**.
- **Liều tiêm bắp Adrenalin (ống 1mg/1ml):** Người lớn tiêm 1/2 đến 1 ống; Trẻ em tiêm từ 1/5 đến 1/2 ống tùy theo cân nặng.
- **Theo dõi và tiêm nhắc lại:** Theo dõi huyết áp 3-5 phút/lần và tiêm bắp nhắc lại Adrenalin cho đến khi mạch và huyết áp ổn định.
- **Xử trí tĩnh mạch:** Nếu mạch không bắt được, huyết áp không đo được sau 2-3 lần tiêm bắp, phải tiến hành truyền nhanh dịch Natriclorid 0.9% và chuyển sang tiêm/truyền tĩnh mạch chậm Adrenalin.
- **Các bước hỗ trợ khác:** Đặt người bệnh nằm đầu thấp, nằm nghiêng trái nếu có nôn, cho thở oxy, ép tim ngoài lồng ngực nếu ngừng hô hấp/tuần hoàn.

IV. Nguyên tắc dự phòng và chuẩn bị

- **Chỉ định dùng thuốc:** Ưu tiên đường dùng thuốc phù hợp nhất, hạn chế tiêm nếu có thể dùng đường khác.
- **Khai thác tiền sử:** Nhân viên y tế phải khai thác kỹ tiền sử dị ứng của bệnh nhân trước khi kê đơn và ghi rõ vào hồ sơ bệnh án.
- **Test da:** Không bắt buộc thử phản ứng (test da) cho tất cả các loại thuốc, trừ những trường hợp có chỉ định đặc biệt của bác sĩ.

- **Trang thiết bị:** Hộp thuốc cấp cứu phản vệ (chứa sẵn Adrenalin, bơm kim tiêm, thuốc kháng histamin, corticoid...) phải luôn sẵn sàng tại nơi sử dụng thuốc, xe tiêm, cơ sở y tế và các phương tiện giao thông công cộng.
- **Cấp thẻ dị ứng:** Cấp "Thẻ theo dõi dị ứng" cho bệnh nhân khi đã xác định được nguyên nhân gây phản vệ để họ mang theo người.
- **Sử dụng khẩn cấp:** Người có tiền sử phản vệ có thể mang sẵn Adrenalin và bất cứ ai (kể cả không phải nhân viên y tế) cũng được phép tiêm bắp cấp cứu cho họ trong tình huống khẩn cấp.